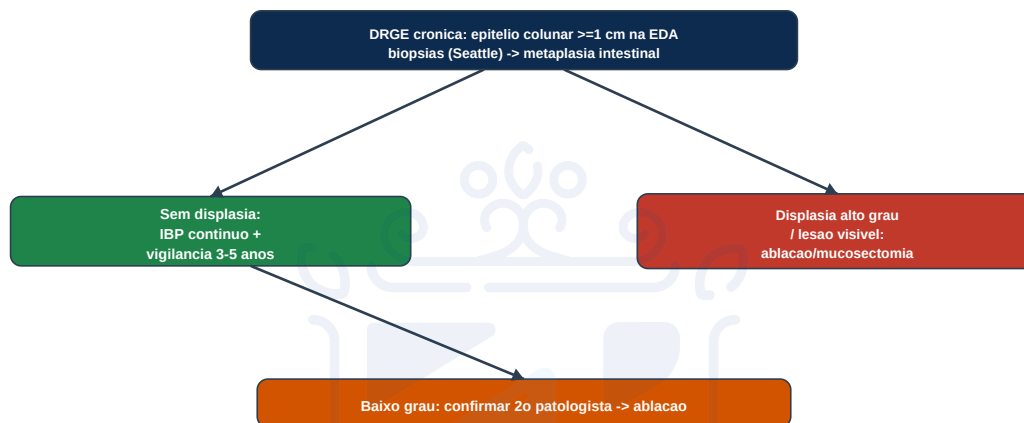


ESÔFAGO DE BARRETT — DISPLASIA GUIA

FLUXOGRAMA — DISPLASIA GUIA A CONDUTA

BARRETT — BIÓPSIA -> GRAU DE DISPLASIA



DEFINIÇÃO E RISCO

METAPLASIA INTESTINAL

- Substituição do epitélio escamoso esofágico distal por epitélio COLUNAR com metaplasia intestinal (células caliciformes), CONFIRMADA por biópsia
- Associado à DRGE crônica; é lesão PRÉ-MALIGNA (adenocarcinoma esofágico)
- Fatores de risco: DRGE > 5 anos, sexo masculino, idade > 50, obesidade abdominal, tabagismo, história familiar de Barrett/adenocarcinoma
- EDA: epitélio colunar >= 1 cm acima da junção esofagogastrica; classificação de PRAGA (C = circunferencial, M = máxima extensão)
- Protocolo de biópsias de SEATTLE: 4 biópsias a cada 1-2 cm do segmento + dirigidas a áreas suspeitas

CONDUTA CONFORME DISPLASIA

Histologia	Conduta
Sem displasia	IBP contínuo + vigilância: curto (< 3 cm) a cada 5 anos; longo (>= 3 cm) a cada 3 anos
Displasia indefinida	Otimizar IBP e repetir EDA em 6 meses
Baixo grau	Confirmar por 2º patologista -> ablação endoscópica (preferencial) ou vigilância anual
Alto grau	Confirmação obrigatória -> ablação por radiofrequência; mucosectomia se lesão visível; cirurgia se falha
Adenocarcinoma	Estadiamento e tratamento oncológico

TRATAMENTO

Rx MEDIDAS + IBP + ENDOSCÓPICO

Medidas antirrefluxo (como na DRGE): perda de peso, elevar a cabeceira, evitar refeições noturnas, cessar tabagismo/álcool, dieta

IBP em DOSE PLENA contínua: Omeprazol 20-40 mg 1-2x/dia, ajustado para controle dos sintomas

Manter IBP indefinidamente, mesmo sem sintomas

Tratamento endoscópico da displasia: ablação por radiofrequência; mucosectomia (EMR) se lesão visível

Cirurgia (esofagectomia) reservada à falha do tratamento endoscópico ou contraindicação

ACOMPANHAMENTO

VIGILÂNCIA É A CHAVE

- Seguimento endoscópico conforme o risco (grau de displasia e extensão)
- Manter IBP indefinidamente; avaliar adesão e sintomas de refluxo
- Displasia de baixo/alto grau sempre confirmada por 2º patologista (variabilidade interobservador)
- O objetivo da vigilância é detectar displasia/adenocarcinoma precoce, tratável por via endoscópica
- Educar o paciente sobre a cronicidade e a importância da adesão

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com DRGE crônica; EDA: segmento de Barrett ____ cm (Praga C__ M__).
- Biópsias (Seattle): metaplasia intestinal confirmada ____; displasia: ausente / indefinida / baixo / alto grau.
- Conduta: IBP dose plena contínuo; vigilância em ____; ablação/mucosectomia se displasia.
- Encaminhamento à gastro/endoscopia para vigilância programada e terapia endoscópica conforme displasia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

O que define o esôfago de Barrett?

- A) Esofagite erosiva sem metaplasia
- B) Substituição do epitélio escamoso por epitélio colunar com metaplasia intestinal (células caliciformes), confirmada por biópsia
- C) Estenose péptica
- D) Hérnia de hiato
- E) Divertículo esofágico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual a conduta no Barrett SEM displasia?

- A) Esofagectomia profilática
- B) IBP contínuo + vigilância endoscópica (3-5 anos conforme a extensão)
- C) Ablação por radiofrequência imediata
- D) Suspender qualquer seguimento
- E) Antibiótico contínuo

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual o tratamento de escolha do Barrett com displasia de ALTO grau sem lesão visível?

- A) Apenas vigilância anual
- B) Ablação endoscópica por radiofrequência
- C) IBP isolado
- D) Funduplicatura
- E) Observação sem IBP

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Por que a displasia no Barrett deve ser confirmada por um segundo patologista?

- A) Por exigência administrativa apenas
- B) Pela alta variabilidade interobservador, que muda a conduta (vigilância x ablação)
- C) Porque o primeiro laudo é sempre incorreto
- D) Para repetir a biópsia
- E) Não é necessário confirmar

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual a principal relevância clínica do esôfago de Barrett?

- A) É uma condição benigna sem implicações
- B) É lesão pré-maligna, associada a risco de adenocarcinoma esofágico
- C) Causa apenas disfagia transitória
- D) Predis põe a carcinoma espinocelular
- E) Resolve espontaneamente com dieta

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Barrett é a substituição do epitélio escamoso esofágico distal por epitélio colunar com metaplasia intestinal (células caliciformes), confirmada por biópsia, no contexto de DRGE crônica.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Sem displasia, mantém-se IBP contínuo e vigilância endoscópica: a cada 5 anos se segmento curto (< 3 cm) e a cada 3 anos se longo (≥ 3 cm).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na displasia de alto grau sem lesão visível, a ablação endoscópica por radiofrequência é o tratamento de escolha; havendo lesão visível, faz-se mucosectomia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O diagnóstico de displasia tem alta variabilidade interobservador e muda a conduta (vigilância x ablação), por isso deve ser confirmado por um segundo patologista experiente.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O Barrett é lesão pré-maligna associada ao adenocarcinoma esofágico — daí a importância da vigilância endoscópica e do controle do refluxo com IBP.

SM24
Suporte ao Plantão Médico